Juarez e as Fronteiras do Cuidado

Embora Juarez tenha perdido a mãe muito cedo – tinha apenas dois anos de idade –, sempre sentiu um vínculo muito forte com ela. Rezava do seu jeito, perto de uma fotografia em que a mãe o segura no colo. Todo mundo falava dela com muito carinho. “Tu tens os olhos dela! Jeito sapeca de ser! Se dá com todo mundo”, ouve frequentemente da avó. E é vó Neuza quem sempre cuidou dele e de tantos outros familiares e vizinhos da comunidade: é que ela carrega um saber que veio de berço – parteira como quem herda terra, nome e jeito de cuidar. É também curandeira e benzedeira de mãos cheias, ainda que hoje não se dedique mais com tanta frequência.

Juarez é um jovem com sonhos. Quer ser enfermeiro e foi para Belém fazer faculdade. Nasceu e viveu toda a sua vida no território quilombola do Alto Itacuruçá com a avó, mulher que cuidou dele desde o nascimento, benzedeira antiga. Os dois, nascidos e criados ali, zona rural ribeirinha do município de Abaetetuba, cidade que tem pouco mais de 150 mil habitantes, um arquipélago de 72 ilhas, onde vivem 40 mil pessoas! O Alto Itacuruçá é um dos muitos quilombos que fazem da cidade a quinta com maior população quilombola do Brasil. A vida de lá é bem diferente da cidade. As casas ficam entre o rio e a mata densa amazônica, impondo um contato direto com a diversidade de plantas, peixes, frutas, pessoas e saberes.

O acesso é fluvial e, dependendo do tamanho da água, pode levar de 50 minutos até 1 hora e meia. As pessoas usam os rabudos (canoas motorizadas, descobertas) e rabetas (pequenas embarcações cobertas e motorizadas) para se movimentar para lá e para cá. O distanciamento com os centros urbanos construiu fortes relações comunitárias, marcadas pelo acolhimento coletivo das dificuldades enfrentadas. Com a ausência das políticas públicas, as pessoas criaram estratégias de cuidado únicas. Como é longe da cidade grande, as pessoas parecem se ajudar mais.

Os dois personagens dessa história, Juarez e vó Neuza, aparecem no CAPS assustados e cansados, trazendo um encaminhamento de um Hospital Psiquiátrico em Belém, onde passaram os últimos três dias e onde viveram emoções intensas. “A cidade deixou ele assim”, diz ela. Durante a conversa, vamos conhecendo mais sobre sua família, com longa linhagem de pescadores artesanais e pequenos agricultores de açaí, ofícios que atravessam várias gerações de seus antepassados. Seu pai sempre esteve por perto, mas, em função da pesca, passa mais tempo viajando do que em casa, mantendo uma relação de cuidado mais financeira que afetiva.

Dona Neuza se orgulha de ter carregado mais de 80 crianças e se lamenta que perdeu duas – mas foram apenas duas. Seu cuidado não se dava só na hora do parto, mas se estendia no antes e depois. Trazia sempre uma malinha com o "*kit* das parteiras" concedido pela Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa) e suas garrafadas poderosas, contendo um pouco de tudo: jucá, for sangue, barbatimão, andiroba, copaíba, mel de abelha, alho, entre tantos outros elementos de seu quintal farmacêutico. Orientava sobre o preparo, o armazenamento, as indicações e o tempo de uso. Mas sempre frisava: "A natureza é a terra dos encantos! Pede licença e benção para a mãe sempre antes de usar!". Em algumas dessas visitas, Juarez estava por perto, prestando atenção. Sempre participava dos momentos com muita alegria e não tardou em se familiarizar com esses fazeres. O interesse foi tanto que levou Juarez a cursar Enfermagem, tendo que se deslocar para a capital paraense, já que ainda não havia cursos em seu município. Um grande desafio para um rapaz de apenas 17 anos.

A mudança não foi fácil: Belém é muito diferente! O tempo passa mais rápido, as distâncias são maiores. As pessoas estão sempre correndo. Não tomam banho, se molham. Não fazem refeições, mas engolem comida. Juarez passava quase 3 horas dentro do ônibus quente todos os dias! E ainda teve sorte: alugou uma quitinete no bairro do Marco, não tão distante do Campus Guamá da Universidade Federal do Pará. Reclama sempre de lá: espaço pequeno, apertado e calorento! Não bate vento e é escuro. Sente falta do cheiro da chuva e do canto dos pássaros que avisam a chegada do dia e da chuva. Para lavar e secar roupa, é muito mais difícil. Um monte de pequenas saudades se transformando em tristezas.

As demandas da faculdade também são intensas: aulas teóricas, laboratório, estágios curriculares. Sem falar na pressão que sentiu pela competitividade de seus colegas: tirar sempre as melhores notas, entrar em ligas acadêmicas, aprovar resumos em congressos e publicar artigos. Trabalhar enquanto eles dormem.

E, como muitos deslocados de sua terra, enfrenta desafios: colegas, professores e pesquisadores debocham dele, da sua avó e de tantas outras pessoas que fazem saúde como ele fez. Vive entre dois mundos, aquele da sua ancestralidade, da sua infância e da sua prática como ajudante da vó e o mundo acadêmico que nega o valor do mundo de onde ele veio e legitima só aquilo que é baseado em evidências. Não raramente duvidou de tudo aquilo que aprendeu. Passou a ficar mais calado, ignorava e omitia sua vida com a avó e seu território. Vez ou outra voltava para Itacuruçá, mas as visitas à família foram se tornando raras (além do tempo de deslocamento, ficava muito caro). Foi perdendo contato com os amigos e namorar também parecia uma realidade muito distante. De pouco em pouco Juarez foi mudando.

Cada vez mais isolado, deixou de encontrar colegas depois da aula, e às vezes, quando alguém se encontrava com ele na rua, era ríspido. Começou a ter muitas faltas. Passou a viver noites em claro, mergulhado nos livros ou só pensando e escrevendo. Foi a partir do 7º semestre que as vozes começaram e ouvia palavras duras dizendo para ele ir embora dali e que iria morrer. Cada vez mais assustado, Juarez tentou ignorar, sempre ouvindo música alta nos fones. Resistia e pensava em todos os sintomas estudados na disciplina Atenção à Saúde Mental I.

Certo dia, Juarez chegou cedo na faculdade e não conseguia parar de ouvir aquelas vozes. Trancou-se na sala de aula, impedindo que os colegas de turma entrassem. Estava bastante agitado, temeroso e parecia gritar com alguém. A equipe do SAMU foi acionada e conseguiu acompanhar Juarez até à UPA do bairro. A equipe médica considerou como hipótese diagnóstica "Esquizofrenia, primeiro episódio, atualmente sintomática". Juarez foi medicado e encaminhado para o setor de Emergência Psiquiátrica do Hospital de referência, onde receberia atendimento para avaliação da necessidade de internação.

A equipe psicossocial do hospital avaliou que ele deveria ser internado, justificando para tanto a ausência de rede de apoio: quem poderia acompanhá-lo em casa e realizar as intervenções necessárias? Imaginavam que ele não ia tomar os remédios. Lá usaram muita medicação para reduzir a agitação psicomotora e a intensidade das alucinações. O serviço social conseguiu entrar em contato com a família e com o setor psicossocial da Universidade. Dona Neuza e uma de suas filhas chegariam à Belém somente no final do dia seguinte, e o pai de Juarez só conseguiria retornar da viagem após uma semana. Juarez não se lembra claramente desse processo de ida à UPA e ao hospital.

A chegada da avó e da tia de Juarez possibilitou maior entendimento do histórico dele, da família, do contexto atual que se encontra, dos seus desejos e preferências quanto ao cuidado em saúde e da vida de modo geral. Dona Neuza lembra até hoje da experiência de visitá-lo: usava uma espécie de pijama verde-claro, reclamava do leito em que dormia e se alimentava muito mal. Mas o que mais a chocou foram os olhares distantes, opacos, vazios. Vó Neuza ficou indignada com o que estavam fazendo com o filho dela. Aquele moleque esperto e brincalhão estava desaparecendo. Sua energia se apagava naquele lugar estranho, frio. Sentia a vida de Juarez se apagando e a força dos encantados perdendo seu vigor naquela luz fria do hospital. Era isso que o adoecia. "É que, para manter essas forças vivas, a gente precisa da terra, da mata, do rio. Aqui, assim, não dá para cuidar dele", dizia.

Após dois dias dormindo na recepção do hospital e muitos convencimentos da família para liberarem Juarez, a alta foi dada com o comprometimento da família de realizar o acompanhamento no CAPS II do município e de ele tomar as medicações prescritas. Retornaram às próprias custas para Abaetetuba e, antes de voltarem para a comunidade ribeirinha onde moravam, foram acolhidos pela equipe do Centro. Outra etapa começou nesse momento.

A equipe do CAPS não estava acostumada a lidar com as demandas que Juarez apresentava pela perspectiva dos saberes de seus antepassados. Ela sabia da existência, mas a relação com eles era de distanciamento e desdém, assim como era na faculdade em Belém. Parte da equipe entendia tudo isso como bobagem, coisas nas quais não deviam prestar atenção e integrar ao CAPS. Outra parte tinha respeito pelas tradições, mas ficava calada, não se sentia à vontade de dizer que, se nada desse jeito, sabiam que a dona Neuza resolvia. Entretanto, a maioria não sabia o que era.

A história de Juarez fazia com que todos precisassem aceitar a existência da sua história, senão fariam como na faculdade e apagariam sua origem. O olhar viciado induzia a equipe a priorizar os sintomas, as vozes, isolando-os da pessoa, da origem e dos saberes que carregava desde sempre. Preocupados em diminuir sintomas, o consenso era seguir com a medicação e agendar os retornos para atendimentos individuais e grupais. Estabeleceram essa direção terapêutica, mas, no fundo, mesmo sem ninguém ter falado nada, sabiam que aquilo fracassaria. Um tom de pena acompanhava as discussões. O CAPS é longe da casa de Juarez e ele sentia muito medo de pensar em retornar à Belém ou de ficar longe do Itacuruçá.

Certo dia, em reunião, alguém teve uma ideia. O profissional lembrou que, em sua família, uma tia-avó era benzedeira e desconfiava muito da medicina da cidade, e que, quando estava velhinha, só aceitou ser consultada por um médico porque ele foi até ela, e tinha paixão por fitoterápicos. Conversou muito sobre as plantas do jardim. Decidiram ir atrás desse médico, que talvez ainda estivesse na UBS para fazer a consulta com a psiquiatra do CAPS na casa de Juarez. A médica ficou ligeiramente apreensiva, já que nunca tinha ido até aquele lado do território. Daiane, auxiliar de enfermagem, se voluntariou a ir junto, pois conhecia tudo por lá.

A saída do CAPS e a ida ao rio apresentaram dificuldades e potências de fazer saúde mental por ali. A intensidade das águas, do vento e da floresta promove experiências únicas. Tem coisas que são difíceis de traduzir, mas os afetos comunicam. A chegada à casa de dona Neuza era aguardada por familiares e outras pessoas da comunidade. Um misto de alegria do reencontro e preocupação com Juarez.

Sentiram as boas-vindas e as acolhidas, com alguns olhares de desconfiança e surpresa. Juarez parecia mais tranquilo, embora ainda sonolento. Comunicava-se mais que outrora. Sua vó não desgrudava dele. Ao adentrarem na casa, acessaram um cômodo grande, com divisões de quartos. No início, móvel com TV e sofá. Em seguida, o espaço de dormir. Lá no fim, a cozinha com a mesa de jantar. O banheiro fica fora da casa, no qual precisa atravessar uma pequena ponte de madeira para chegar. Seguiram para o canto de Juarez, onde fica estendida sua rede e o armário com seus pertences. Ele se deitou e dormiu.

A equipe foi até a frente da casa, para conversar sobre o que fazer. Dona Neuza deixava claro que não confiava na medicação, nas terapias agendadas e nas orientações recebidas tanto no hospital quanto no CAPS. Colocava suas décadas de experiência como autoridade máxima frente à saúde do neto. Outras pessoas testemunharam a potência do cuidado dela, compartilhando várias experiências exitosas dessa e de outras condições. Aqui, a equipe se deparou novamente com um movimento de resistência às práticas de cuidado, mas agora direcionado para a “medicina branca” e “medicina da cidade”, que era como eles chamavam. Foi então que a equipe pediu para eles explicarem como entendiam o acontecido com Juarez, para compreender as formas de pensar e fazer saúde mental.

Dona Neuza chamou de problema o que Juarez apresentava. Ensinou que “problema” é diferente de “doença”, pois afeta primeiramente a alma para depois afetar o corpo. O problema pode aparecer por razões espirituais ou por questões da vida. Embora não tivesse certeza da origem do problema dele, por conta da distância dos últimos anos, ela já sabia o que tinham que fazer para curar: realizar trabalhos, um conjunto de práticas de cuidados físicos, alimentares, medicamentosos e espirituais. Benzimentos, rezas, jejuns, chás e defumações. Também era importante que ele entrasse na mata, para ouvir o que os encantos tinham a dizer. Ele também precisava estar sempre acompanhado. A solidão é sempre um perigo.

Dona Neuza, o médico da UBS, a psiquiatra e Daiane passaram duas horas conversando e organizaram uma rotina de cuidados. Pouca articulação foi preciso, pois já sabiam o que fazer. Dona Neuza pediu a uma filha que preparasse a janta enquanto iniciaria seus preparos para os trabalhos. Decidiram que a primeira ação seria fazer da chegada dele uma espécie de ritual de boas-vindas. As pessoas presentes voltaram para suas casas e retornaram ao final da tarde. A equipe de saúde se colocou à disposição para o apoio necessário, reforçando as orientações já repassadas, e trocaram números de contatos com dona Neuza. Combinaram de retornar após dois dias. Ela agradeceu e pediu para um de seus netos levar a equipe de volta à Abaetetuba.

Ao retornar, o médico da UBS, a psiquiatra e Daiane conversaram com o restante da equipe do CAPS sobre a visita. Colocaram as impressões deles sobre o cuidado da rede de apoio. O sentimento de que Juarez estava mais calmo e comunicativo do que quando havia chegado. A médica se sentiu confiante pela primeira vez que ele teria toda a atenção e a proteção necessárias da família e da comunidade. Ela voltou animada, fazendo planos com o médico da UBS de uma farmácia viva. A equipe nunca tinha visto a médica assim antes. Parecia que o território tivesse feito maravilhas para todo mundo!

Além disso, todos conversaram sobre as resistências que tinham que manejar, tanto internamente quanto com o território, pois era quase certo que, se não trabalhassem essas questões, não haveria acompanhamento. Era necessário construir a proposta de cuidado integrando as práticas e os saberes da atenção psicossocial às do território. Senão, fariam da mesma forma como foi a experiência de Juarez na faculdade: diminuindo o seu saber a crendices. No entanto, ainda que com dificuldades, combinaram de retornar essa discussão após a segunda ida ao encontro de Juarez, na expectativa de que ele pudesse estar mais comunicativo e aberto ao diálogo.

A preparação para o encontro envolveu ainda mais a mobilização da Unidade Básica de Saúde do território. A coordenação da instituição foi acionada e inteirada da situação, sendo convidada para o encontro. Iraneide, agente comunitária de saúde de referência do Alto Itacuruçá, confirmou presença. O CRAS também foi mobilizado, mas, em função da agenda atribulada, não poderia estar no dia combinado. Ofereceria ações e serviços em outra oportunidade.

Na data estipulada, os profissionais de saúde se encontraram com Iraneide no porto. Aproveitaram a oportunidade para conversar sobre a comunidade, as relações que estabelecem com a UBS e os saberes tradicionais. Ela ficou magoada porque não tinha ido da primeira vez e alertou da necessidade de acolher os saberes que fazem parte da comunidade como condição para que o vínculo seja fortalecido com os serviços. Quando chegaram, Juarez estava sentado, tomando café. Sua aparência estava consideravelmente melhor. Expressava mais afetos por meio de sorrisos, olhares e gestos. Conversava mais. Dona Neuza estava lavando louça, cumprimentou a ACS com um abraço e fez questão de servir café com rosquinha.

Juarez agradeceu o acompanhamento do primeiro dia, embora não se lembrasse com detalhes de tudo. Contou dos desafios que estava enfrentando em Belém, com o distanciamento de sua família e comunidade e com as exigências da faculdade. Sentia um vazio muito intenso e cansaço. Ao mesmo tempo, estava feliz em poder se formar e ser o primeiro da família a concluir o ensino superior. Tinha a impressão de que desistir seria uma decepção para todos, tendo que aguentar as dificuldades que fazem parte do processo. Aos poucos, foi se afastando das pessoas,

dos seus hábitos e das suas crenças. Comentou que o início das vozes aconteceu em sonhos, os quais, ao passar do tempo, foram se tornando mais violentos. Evitava dormir para não sonhar. Foi quando as vozes se fizeram presentes enquanto acordado que tudo piorou. Juarez dizia que entendia o que estava passando a partir das duas visões de mundo que havia conhecido. Dizia-se aliviado pelo silêncio. Não ouvia mais as vozes, nem tinha sonhos com elas, mas ainda estava inseguro para voltar. Ao mesmo tempo, estava preocupado com o andamento da sua graduação e do projeto de pesquisa com o qual estava envolvido.

Foi então que a equipe de saúde combinou de entrar em contato com a coordenação do curso, do projeto de pesquisa e do setor psicossocial da UFPA, a fim de construir algum tipo de ajuste pedagógico nos processos formativos. Outro ponto importante na conversa foi a preparação para possíveis episódios de crise. Como ele gostaria de ser cuidado? Entre as estratégias às quais havia sido submetido, com quais ele se sentiu mais acolhido e quais lhe foram mais difíceis? Que pessoas devem ser contactadas? O que elas devem fazer? O que não fazer?

Juarez contou, com muita dificuldade, dos dias internado no hospital. Lembra-se de gritos, de sentir muito medo e de ter sido contido em determinado momento. Acordou suando, muito agoniado. Chamou por ajuda, mas ninguém veio. Recordava apenas da técnica de enfermagem. Ela era cuidadosa e, mesmo sem conseguir responder, conversava com ele, explicando onde estava, como estava, informando a situação da família e outras questões da vida dele. Lembra-se mais claramente do encontro com a vó. “Era como um ser de luz! Chorei muito! Foi um alívio muito forte. Me senti seguro pela primeira vez”, disse. Quanto ao uso de medicação, lembra-se do efeito pesado que o impossibilitava de ficar acordado, de falar e de organizar seus pensamentos. Tinha apagões.

A partir disso, desejava evitar radicalmente outras internações, bem como o uso de qualquer medicação. Gostaria que as pessoas conversassem com ele, indicando o que está acontecendo, o local onde está. Escolheu a casa da vó Neuza como lugar de preferência e ela como pessoa principal para tomar decisões e acompanhá-lo no que fosse preciso; a prima, vizinha, também.

Juarez escolheu ficar na casa da avó temporariamente, enquanto se recuperava. Além de matar as saudades, estava se reconectando consigo, exercendo o seu bem viver e reavaliando suas escolhas. Não sabia se voltaria à Belém, mas ainda desejava concluir o curso. As idas ao CAPS também não seriam possíveis ainda. As decisões de Juarez e de sua família foram respeitadas e foi feito de tudo para que a faculdade mantivesse a matrícula de jeito que fosse possível de Juarez voltar.

Dona Neuza compartilhou com a equipe de saúde o que havia compreendido até o momento. Durante um de seus trabalhos, um caboclo usou seu corpo para confrontar Juarez. Era Tupiaçu, guia do mato que afasta espíritos do mal, quebra o mau olhado e desvia os assombros. Tupiaçu disse a Juarez que, por ter abandonado suas tradições, tinha se enfraquecido, ficando vulnerável aos feitiços da cidade, à inveja das pessoas e a outros problemas. Indicou conversas, conselhos, rezas, benzimentos, banhos de cheiro, tomar chá de hortelã e erva-cidreira diariamente. Dona Neuza disse que ele estava ficando mais forte e cada vez mais perto da cura.

Ficou combinado, então, que Iraneide iria visitar Juarez todos os dias durante esse momento. A ideia era compreender de que outras formas a equipe poderia apoiar o cuidado que estava acontecendo. Também tentaria uma visita com a equipe da UBS Fluvial que estaria ali perto alguns dias depois. A psicóloga de lá foi orientada sobre Juarez e suas preferências para o cuidado. O retorno seria na semana seguinte. Quanto a Juarez, dona Neuza e a comunidade, sugeriu-se que continuassem com as práticas que já estavam realizando e a equipe se colocou à disposição para o apoio necessário.

Nas semanas seguintes, a equipe de saúde retornou à casa de dona Neuza. Aqueles olhares desconfiados foram substituídos por sorrisos e abraços. Boas-vindas, mais café e mais rosquinhas. Nesse dia, Juarez estava na mata, apanhando açaí para o almoço. Sua vó convidou todos a irem até lá, conhecer seu quintal: uma verdadeira farmácia viva. Explicava, com muito cuidado, cada planta, raiz, semente, casca e alimento que tinha ali. Também falava de Juarez, dizendo que as vozes não tinham voltado e que estava forte e alegre. “A cabeça dele não está mais pra baixo”, disse. Seguindo mata adentro, encontraram Juarez, sorridente, falante e afetuoso. Conversaram por ali mesmo.

Ele reconhecia estar bem melhor e se sentindo mais seguro. Estava na expectativa da vinda da equipe de saúde, pois queria ir com eles até o CAPS para conhecer o serviço e ensaiar a primeira saída. Pediu que conversassem juntos com sua vó, que não gostava nada da ideia. Conseguiram negociar com ela a ida, desde que ela os acompanhasse. Juarez seguia desejoso de encerrar o ciclo que começou e pediu o apoio da equipe para isso. Enquanto se arrumavam, Juarez mostrava para a sua comunidade: a escola onde estudou, o campo onde jogava bola e empinava pipa e a canoa que usava para se deslocar. A casa onde auxiliou sua vó no primeiro parto que pôde acompanhar.

A história de Juarez é sempre embolada com o trabalho de cuidado na comunidade. Há uma força muito poderosa nele. Foi então que se percebeu melhor a vontade de se formar enfermeiro... Ele sente que tem como missão de vida carregar o legado de sua vó, de sua bisavó e de outras pessoas que fazem saúde por ali. É um guardião da vida, da memória e dos saberes forjados no território. Quer contar com a equipe de saúde nos desafios que vai enfrentar daqui para frente.

Durante o trajeto de ida ao CAPS, Juarez estava apreensivo e agarrado na vó. Ao chegar, alguns colegas presentes foram apresentados. Andaram pela casa que é sede do serviço, apresentando o espaço para os convidados. Juarez conversou bastante com a enfermeira. Em alguns momentos, a equipe sentia estar realizando uma visita técnica: eram muitos “Juarezes” ali. Após a visita, um pouco mais de café, rosquinha e conversas, Juarez e a vó foram acompanhados até o porto, de onde embarcaram de volta. Além de um cartão com os atendimentos agendados, eles levaram consigo um pouco mais de esperança.

A partir desses encontros, alguns efeitos foram importantes. Em primeiro lugar, a equipe pôde compreender a história de Juarez, seu processo de desenvolvimento psicossocial, as relações estabelecidas com seu território, sua família, suas relações importantes com amigos, suas práticas de cuidado, os hábitos que produziram um contexto de saúde mental potente, em que sinais e sintomas de sofrimento psíquico não se faziam presentes da forma como era. Da mesma maneira, os impactos que as quebras abruptas dessas relações dispararam na saúde e na qualidade de vida de Juarez: o afastamento do território, a mudança para Belém, a adoção de modos de vida alheios e o trabalho acadêmico como fatores de grande vulnerabilidade e risco emocional. Assim, foi construído o projeto terapêutico singular que pudesse conciliar o desejo de Juarez de ser graduado em Enfermagem pela Universidade e a preservação do modo de vida que sempre lhe garantiu bem viver.

O setor psicossocial da Universidade foi provocado pela equipe de referência para a construção do plano educacional individualizado em face das demandas específicas de Juarez. Agendou-se um encontro virtual com a psicóloga do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, no qual foram compartilhados alguns desafios e expectativas de Juarez sobre sua vida acadêmica. Ainda que receptiva à demanda, ela informou da necessidade do laudo médico psiquiátrico para que ele pudesse gozar dos ajustes solicitados. Aqui retoma-se um velho problema: a condicionalidade da garantia de direitos diversos à tutela do saber-poder médico. A equipe de saúde alegou que cabe também às instituições de ensino a garantia do direito à saúde e à inclusão de pessoas nos processos formativos a partir de várias demandas, como as de Juarez.

Depois de muitos embates, foram construídas estratégias para a conclusão de disciplinas obrigatórias à distância, com um plano de ensino especial, transformando os encontros e os processos avaliativos. Da mesma forma, os estágios curriculares obrigatórios foram realizados no Hospital Regional de Abaetetuba, evitando o deslocamento diário à capital, que passou a ocorrer somente na última semana do mês.

Outro ponto importantíssimo foi a participação da família e da comunidade. Todo esse processo era acompanhado de perto pela família de Juarez, que estivera com ele cotidianamente. Entre idas e vindas ao CAPS, no deslocamento para a sede de Abaetetuba, nas semanas em que precisavam ir à Belém e em outros processos importantes. Os vínculos familiares e comunitários foram muito importantes para o manejo da crise, especialmente nas primeiras semanas, quando as pessoas da comunidade criaram uma estratégia de plantão domiciliar na casa da família, revezando as responsabilidades pelo cuidado integral dele. Tias, primos e amigos montaram escala de visitas e estadias. Cafés, almoços, lanches e jantas coletivas foram organizados.

Embora essa participação tivesse sido orientada, entendeu-se que a construção foi promovida pela própria comunidade. Afinal, o deslocamento para as ilhas do município ainda é uma dificuldade enfrentada pela equipe de saúde. Nesse ponto, a ACS do território fazia atualizações frequentes, embora ela fosse uma das pessoas que sempre criticara o CAPS. Em reunião de matriciamento, ela havia dito que o CAPS não servia para nada. Mas a relação com Juarez nesse percurso transformou a relação com o CAPS também. Juarez era um menino por quem ela tinha muito carinho, moravam na mesma comunidade e Iraneide brigava muito por ele. A equipe de saúde ficou muito próxima dessa ACS e ela afirmou que estava pensando em cursar Terapia Ocupacional em Belém. Ela era importante também para renovar a fé no CAPS por parte de dona Neuza.

As relações com as Unidades Básicas de Saúde e as equipes de Estratégia Saúde da Família ainda são muito frágeis e precisam ser fortalecidas. Juarez se dá bem com outros cuidadores tradicionais, como pais e mães de santo, curandeiras, erveiras, puxadores e tantos outros personagens importantes.

A retomada das práticas de cuidados que sempre fizeram parte da vida de Juarez também fora fundamental: dedicar-se à sua ancestralidade, à sua psicoespiritualidade, participar de momentos de rezas e benzimentos, preparar as garrafadas com sua vó, tomar banho de rio, tomar café na ponte e tantas outras experiências possibilitaram que esses episódios fossem superados. Com o passar do tempo, ele pôde compreender que as vozes que lhe incomodavam eram chamados para voltar para casa. Foram mensagens de seus ancestrais para que pensasse nas suas escolhas, sua família e seu bem-estar.

Hoje, Juarez entende tudo o que passou como uma lição de vida: não pode subjugar, menosprezar, diminuir e ignorar os encantos da terra. Ele é o rio, é o vento, é o barulho da mata. Perto disso, fica bem. Longe disso, passa mal.

Juarez se formou enfermeiro, como sonhara desde menino. Embora reconheça a importância dos saberes produzidos pelas ciências da saúde que estudou e com os quais atua no cotidiano de trabalho, identifica, valoriza e utiliza os saberes ancestrais nas suas práticas. Entende que práticas diferentes, construídas a partir de saberes diferentes, constroem diferentes cuidados. Nesse processo, compreende que ele é mais que um corpo: é um corpo que é território. Corpo-território que não separa o “eu” do “outro”, do ambiente, dos seres vivos e não vivos, do presente e do passado. E que sua existência só é possível quando condicionada a este. Dona Neuza viu Juarez pegar o canudo e sua filha chorar, por meio do rosto de seu neto.